

TEMA 1.6 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Hernias

PERFIL EUNACOM 4.01.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología de la Pared Abdominal: Hernias

La fisiopatología herniaria consiste en la protusión de órganos o tejidos intraviales a través de un orificio parietal natural o debilidad iatrogénica de las capas musculares periféricas.

Tipos Anatómicos de Hernias

Existen topografías características en el defecto anatómico: -

Hernia Inguinal Indirecta: Es la más frecuente de forma global y general (en hombres y mujeres). Protruye por el **anillo inguinal profundo (interno)** y puede discurrir por el trayecto espermático (generando el cuadro inguino-escrotal en hombres). Su anatomía de protrusión corre de manera **lateral** a los vasos epigástricos inferiores. - **Hernia Inguinal Directa:** Herniación debida a debilidad de pared por el **Triángulo de Hesselbach**. Protruye directamente y ocurre de forma **medial** a los vasos epigástricos inferiores. Más rara que la indirecta. - **Hernia Femoral (Crural):** Discurre por abajo del ligamento inguinal (anillo/triángulo femoral). En proporción, es más frecuente de hallar en mujeres que en hombres, aunque la indirecta siga liderando la estadística cruda. - **Hernias no inguinales comunes:** - **Umbilical:** Específica a la zona cicatriz umbilical. - **Lumbar (Hernia de Petit):** Triángulo lumbar inferior clásico dorsal posterior. - **Hernia de Spigel (Línea Semilunar):** A orillas de la cara del borde externo tendinoso del músculo recto abdominal hacia una proyección inferior y lateral (borde de las "calugas").

PERLA CLÍNICA EUNACOM

No sobrecomplices la estadística demográfica: La hernia inguinal indirecta es la más frecuente en absoluto y generalizado, mientras que, hablando en un grupo específico de hernias, es necesario distinguir la epidemiología por sexo.

Evolución y Complicaciones Herniarias

Las formas evolutivas se diferencian en tres esquemas patogénicos:

- **Atascada (Encarcerada):** Irreductibilidad de la víscera hacia la cavidad acompañada de dolor intermitente constante incipiente.
- **Estrangulada:** El mismo atascamiento irreductible avanza, gatillando oclusión arterial que resulta en **compromiso vascular activo** y alto riesgo de necrosis progresiva masiva. A la inspección se vislumbra como una tumoración de tinte violáceo y isquémica indurada con fiebre y letargia.
- **Obstrucción Intestinal:** Oclusión paralela intra-víscera por constreñimiento a tensión extrema. Es un íleo mecánico primario (las hernias son la segunda causa absoluta de obstrucción de ID).

Tratamiento de la Hernia

- **Asintomática o No complicada: Cirugía Electiva** (toda hernia patológica debe ser operada de urgencia diferida). Si existen comorbilidades de gran impacto (ej. IAM reciente), se aplazará para prever un riego de sedación. A final de cuentas se realiza de todas formas la Hernioplastia quirúrgica.
- **Complicada (Atascada, Estrangulada u Obstrucción asociada):** Se indica **Cirugía de extrema Urgencia**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Excepción Pediátrica Específica: Si un menor de 4 años recién nacido u infante ostenta una Hernia Umbilical, la acción dictamina **observación expectante**, aguardando resolución fibrilar espontánea conforme al cierre de pared. Si supera la línea de los 4 o 5 años asintomática, sí pasará a procedimiento quirúrgico por falla parietal crónica. En cambio si es una Hernia Inguinal Pediátrica (aunque el niño no tenga ni un mes), **OPERACIÓN obligatoria directa**.

Obstrucción Intestinal

La obstrucción intestinal comprende la detención del tránsito de gases y deposiciones, provocando congestión anatómica reaccionaria y posible compromiso necrótico por distensión secundaria vascular de la pared del colon e intestino.

Clínica y Diagnóstico

- **Tríada Clásica Inicial:**
- Dolor abdominal agudo generalizado cólico espasmódico.
- Vómitos (Alimentarios tempranos en etiologías altas, Fecaloídeos muy tóxicos en cuadros isquémicos/bajos tardíos).
- Distensión abdominal severa volumétrica progresiva.
- Ausencia/Cesación prolongada de la expulsión de gases distales anales.
- Ruido Intestinal metálico inicial debido al esfuerzo peristáltico que evoluciona rápidamente a **silencio abdominal isquémico de irritación peritoneal difuso final** (Sg. Blumberg (+)).
- **Estudios Auxiliares:**
- **Radiografía Simple de Abdomen:** *Examen de elección principal orientativo EUNACOM.* Manifiesta Niveles Hidroaéreos marcados, distensión de cámara del ID e imagen de las válvulas conniventes difusas plicadas (pila de monedas colónicas).
- **TAC Abdominal (Scanner):** Elección resolutive en contexto de masas pélvicas malignas u orden oncológico confirmatorio y causal de la obstrucción (como un cáncer impactado).

Etiopatogenia en Obstrucción de Intestino Delgado y Colónico

- **Región Intestino Delgado (ID):**
- Adherencias y Bidas peritoneales post-traumáticas/post-Qx previas. (1º Causa).
- Hernias atascadas de pared. (2º Causa).
- Íleo Biliar.
- **Región Colon/Intestino Grueso:**
- Cáncer Colorrectal (1º Causa colónica absoluta). Genera signos paraneoplásicos paralelos asociados (baja de peso progresiva, constipaciones reincidentes y hematoquecia crónica/anemia ferorreparativa).
- Diverticulitis aguda abcesada y ocluida.
- Vólvulo de Sigmoides.

Frecuencias Patológicas Específicas

- **Íleo Biliar:** Obstrucción generada por el viaje errante de un macrocálculo litiasico originario que perfora una fístula colecistoduodenal isquémica, el cual viaja impune a través del tracto duodenal hasta llegar y obturarse definitivamente en la zona más angosta (Válvula Íleocecal). La imagen típica en la semiología radiológica resalta por una Tríada simultánea: Obstrucción intestinal basal focal en fosa iliaca derecha, neumobilia (aire en vía biliar en el TAC) y cálculo calcificado distópico.
- **Vólvulo de Sigmoides:** Rotación u enrosque axial fulminante de base sobre un mesocolon sigmoides redundante desproporcionado. Radiológicamente se percibe mediante un inmenso asa neumatizada

pélvica configurando un signo visible como un inmenso **"Granos de Café"**.

- *Tratamiento Inicial Único de Diferencia:* A diferencia de todos los ileos obstructivos y patologías compresivas, el vólvulo **NO se opera de urgencia como primera elección de vía**. Exige descompresión colposcópico / neumático rectosigmoideo resolutivo bajo endoscopia/desenroscos con sonda (solo si es viable y no existen signos de peritonitis necrotizante fulminante).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un hombre de sesenta años con antecedente de apendicectomía hace diez años llega a urgencias con dolor abdominal cólico, vómitos fecaloideos y distensión abdominal progresiva. La radiografía muestra niveles hidroaéreos y asas dilatadas. ¿Cuál es la causa más probable de obstrucción intestinal?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hernias. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La hernia inguinal indirecta es la más frecuente de todas las hernias y es más común en hombres; la femoral es más frecuente en mujeres.
- Las hernias complicadas (atascada, estrangulada, con obstrucción intestinal) se operan de urgencia; las no complicadas se operan de forma electiva.
- La hernia umbilical en niño menor de cuatro años se observa porque habitualmente se resuelve espontáneamente; si es inguinal se opera siempre.
- La obstrucción intestinal se presenta con dolor cólico, vómitos y distensión abdominal; el diagnóstico es clínico y la radiografía de abdomen confirma.
- La causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado son las bridas y adherencias; la segunda causa son las hernias.
- El vólvulo de sigmoides muestra imagen en grano de café en la radiografía y se trata con descompresión neumática, no cirugía.
- Todas las hernias se operan con hernioplastia, que puede incluir malla para evitar recidiva.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HERNIAS)

PREGUNTA 1

Un hombre de sesenta años con antecedente de apendicectomía hace diez años llega a urgencias con dolor abdominal cólico, vómitos fecaloideos y distensión abdominal progresiva. La radiografía muestra niveles hidroaéreos y asas dilatadas. ¿Cuál es la causa más probable de obstrucción intestinal?

- A) Hernia inguinal estrangulada
- B) Bridas y adherencias por cirugía previa
- C) Vólvulo de sigmoides
- D) Cáncer de colon obstructivo
- E) Íleo biliar

PREGUNTA 2

Una paciente de cuarenta años consulta porque al palparse nota un aumento de volumen en la región inguinal izquierda que se hace más evidente al toser y que se reduce al acostarse. No hay dolor ni signos de complicación. ¿Cuál es la conducta?

- A) Observación, no se opera porque es pequeña
- B) Hernioplastia electiva
- C) Hernioplastia de urgencia
- D) Uso de braguero de forma indefinida
- E) Derivación urgente a cirugía por riesgo de estrangulación inmediata

PREGUNTA 3

Un lactante de dos meses llega al control con un aumento de volumen en el ombligo que aumenta al llorar y se reduce espontáneamente. No hay signos de complicación. ¿Cuál es la conducta?

- A) Hernioplastia urgente para evitar estrangulación
- B) Observación hasta los cuatro años, operar solo si no se resuelve
- C) Hernioplastia electiva a programar en los próximos meses
- D) Derivación a cirugía pediátrica para cirugía inmediata
- E) Control en dos años y evaluar

RESUMEN: HERNIAS

Las hernias se clasifican según su localización. Las hernias inguinales incluyen la indirecta, que atraviesa el anillo inguinal interno y puede llegar al escroto, siendo la más frecuente de todas. La hernia directa atraviesa el triángulo de Hesselbach medial a los vasos epigástricos. La hernia femoral atraviesa el anillo femoral bajo el ligamento inguinal y es más frecuente en mujeres. También existen la hernia umbilical, lumbar y de Spiegel. La eventración o hernia incisional es la que protruye por una herida quirúrgica previa. Las complicaciones de las hernias son la hernia atascada o encarcerada, que es irreductible y dolorosa; la hernia estrangulada, que además tiene compromiso vascular del contenido; y la obstrucción intestinal. La hernia umbilical en niños menores de cuatro años se observa porque habitualmente se resuelve espontáneamente. Todas las demás hernias se operan de forma electiva con hernioplastia. Si están complicadas se operan de urgencia. La obstrucción intestinal se presenta con dolor cólico, vómitos que pueden ser fecaloideos, distensión abdominal y ruidos aumentados. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en el intestino delgado son las bridas y adherencias. La segunda causa son las hernias. El diagnóstico es clínico y el examen de apoyo es la radiografía de abdomen simple. El vólvulo de sigmoides muestra imagen en grano de café y se trata con descompresión neumática, no cirugía.